

GUIA DE ESTUDIO PROFUNDA DEL TFM

"Como afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar. Una revision paraguas de meta-analisis en psicologia clinica y de la salud (2016-2026)"

Para entender cada apartado en profundidad

PARTE 1 -- MARCO TEORICO EN PROFUNDIDAD

1.1 El self: que es y por que importa

El concepto de **self** (en espanol: el yo, el si-mismo) es uno de los mas estudiados en psicologia. Hace referencia a la representacion mental que una persona tiene de si misma: quien soy, como soy, cuanto valgo.

¿Por que es tan importante? Porque la forma en que nos percibimos a nosotros mismos guia nuestra conducta, filtra la informacion que recibimos del entorno, y determina como respondemos emocionalmente a las situaciones. Un self negativo produce sesgos cognitivos negativos (atencion selectiva al fracaso, interpretacion catastrofista), emociones negativas recurrentes, y conductas de evitacion o autoboicot.

1.2 Historia del concepto de self

Autor | Ano | Aportacion clave

William James | 1890 | Distincion Yo (I, agente) vs Mi (Me, objeto de conocimiento). El Mi incluye el self material, social y espiritual.

Charles Cooley | 1902 | "Self del espejo": nos vemos como creemos que nos ven los demas. La imagen social moldea el autoconcepto.

George H. Mead | 1934 | El self emerge en la interaccion social. El "otro generalizado": internalizamos las expectativas del grupo.

Erik Erikson | 1950s | La identidad del yo como tarea del desarrollo adolescente. Crisis de identidad.

Morris Rosenberg | 1965 | Introduce la ****Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES)****: 10 items, Likert de 4 puntos. Sigue siendo el gold standard mundial. Define autoestima como "actitud positiva o negativa hacia uno mismo como objeto".

Shavelson, Hubner & Stanton | 1976 | Modelo jerarquico y multidimensional del autoconcepto. En la cima: autoconcepto general; debajo: academico y no academico; mas abajo: verbal, matematico, fisico, social...

Herbert Marsh | 1990s | Desarrolla el ****SDQ**** (Self-Description Questionnaire) para medir el autoconcepto multidimensional segun el modelo de Shavelson. Introduce el modelo I/E (internal/external frames of reference): el autoconcepto se forma comparandose tanto con uno mismo (en otras areas) como con los demas.

Roy Baumeister | 2003 | Meta-analisis influyente sobre los efectos de la autoestima. Conclusion: los efectos causales de la autoestima son mas modestos de lo que se creia.

1.3 Autoestima vs. Autoconcepto: la distincion crucial

Esta es una de las confusiones mas frecuentes en la literatura, y entenderla es clave para comprender el TFM.

Autoestima

- Es **evaluativa**: implica un juicio de valor sobre uno mismo.
- Es **global**: una valoracion general, no especifica de dominio.
- Pregunta que responde: "¿Me valoro a mi mismo?"
- Instrumento tipico: **RSES** (Rosenberg, 1965).
- Oscila en un continuo de alta a baja autoestima.
- Se ve afectada por: experiencias de exito/fracaso, vinculos de apego, critica social, logros percibidos.

Autoconcepto

- Es **descriptivo**: "como me veo", no "cuanto me valoro".
- Es **multidimensional**: hay un autoconcepto academico, social, fisico, emocional...
- Pregunta que responde: "¿Como soy?"
- Instrumento tipico: **SDQ** (Marsh, 1988) o **PSDQ** (para el fisico).
- No es mejor ni peor; es mas o menos preciso, mas o menos consistente.

Las falacias jingle y jangle

- **Falacia jingle**: usar el mismo termino para dos cosas distintas. Ejemplo: llamar "autoestima" a lo que en realidad es autoconcepto fisico.
- **Falacia jangle**: usar terminos distintos para lo mismo. Ejemplo: llamar "autoconcepto" y "autoimagen" a medidas que correlacionan >0.90 .

Ambas falacias contaminan la literatura e impiden acumular conocimiento de forma coherente.

1.4 El bienestar: cuatro dimensiones que hay que dominar

El bienestar es la variable resultado (outcome) del TFM. No es un constructo unitario. Hay cuatro tradiciones teoricas:

1.4.1 Bienestar subjetivo (hedonico) -- Ed Diener

- **Concepto**: el bienestar es la predominancia de afecto positivo sobre negativo, mas la satisfaccion global con la vida.
- **Tres componentes**: (a) satisfaccion con la vida (cognitivo), (b) afecto positivo (emocional), (c) ausencia de afecto negativo (emocional).
- **Instrumentos**: SWLS (Satisfaction With Life Scale), PANAS (Positive and Negative Affect Schedule).
- **Critica**: es subjetivo y cultural; lo que produce bienestar varia. No distingue entre placer superficial y florecimiento.

1.4.2 Bienestar psicologico (eudaimonico) -- Carol Ryff

- **Concepto**: inspirado en Aristoteles; el bienestar no es sentirse bien, sino vivir bien, desarrollarse.
- **Seis dimensiones**: (1) Autoaceptacion, (2) Relaciones positivas, (3) Autonomia, (4) Dominio del entorno, (5) Proposito en la vida, (6) Crecimiento personal.
- **Instrumento**: Escalas de Bienestar Psicologico de Ryff (SPWB, 18-84 items).
- **Relevancia clinica**: la autoaceptacion y el proposito en la vida son las dimensiones que mas se relacionan con autoestima y autoconcepto.

1.4.3 Calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) -- OMS y otros

- **Concepto:** el impacto percibido de la condición de salud en el funcionamiento físico, psicológico y social.
- **Instrumentos:** SF-36, WHOQOL-BREF, EQ-5D.
- **Relevancia:** es la medida más usada en contextos médicos. Permite evaluar el impacto de enfermedades crónicas, procedimientos y tratamientos sobre el bienestar percibido.

1.4.4 Salud mental positiva -- Corey Keyes

- **Concepto:** la ausencia de enfermedad mental no equivale a salud mental. Keyes añade la dimensión positiva: bienestar emocional, psicológico y social.
 - **Modelo de los dos continúos:** salud mental y enfermedad mental son dimensiones independientes. Se puede tener un diagnóstico y alta salud mental positiva (flourishing), o no tener diagnóstico pero estar en languishing.
 - **Instrumento:** MHC-SF (Mental Health Continuum - Short Form).
-

PARTE 2 -- METODOLOGIA EN PROFUNDIDAD

2.1 ¿Que es una revision paraguas?

Una **revision paraguas** (*umbrella review* u *overview of reviews*) es la síntesis de revisiones sistemáticas y meta-análisis ya existentes sobre un mismo tema. Se sitúa en el nivel más alto de la jerarquía de evidencia.

Jerarquía de evidencia (de menos a más):

- Opinion de expertos
- Series de casos y estudios de caso
- Estudios transversales
- Estudios de cohortes y casos-control
- Ensayos clínicos aleatorizados (RCTs)
- Revisiones sistemáticas y meta-análisis** ← los que incluye este TFM
- Revisiones paraguas** ← lo que es este TFM

Ventajas:

- Visión panorámica del campo.
- Permite detectar inconsistencias entre meta-análisis.
- Evalúa el estado global de la evidencia.

Limitaciones:

- Depende de la calidad de los meta-análisis incluidos.
- No puede acceder a los datos primarios.
- Riesgo de solapamiento entre meta-análisis (controlado con el CCA).

2.2 Guías metodológicas: PRISMA 2020 y PRIOR

PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Guía de 27 ítems que establece que debe reportar una revisión sistemática para ser transparente y reproducible. Incluye:

- Lista de verificación (checklist) de 27 ítems.
- Diagrama de flujo (flow diagram) que muestra cómo pasaron los estudios por las fases de identificación -> cribado -> elegibilidad -> inclusión.

Novedades de la versión 2020 vs. 2009:

- Ítem sobre preregistro.
- Ítem sobre evaluación de la certeza de la evidencia (GRADE).
- Instrucciones específicas para revisiones paraguas (solapamiento, CCA).
- Mayor énfasis en la búsqueda en fuentes de literatura gris.

PRIOR (Preferred Reporting Items for Overviews of Reviews)

Extensión específica de PRISMA para revisiones paraguas. Añade ítems sobre:

- Cómo manejar el solapamiento de estudios primarios entre meta-análisis.
- Cómo sintetizar resultados de meta-análisis con métricas de tamaño del efecto distintas.
- Cómo reportar la heterogeneidad entre meta-análisis.

2.3 El marco PECO

El marco PECO define la pregunta de investigación de forma estructurada:

Elemento | Definición | En este TFM

****P**** (Población) | ¿En quién? | Personas con condición clínica diagnosticada (>=75% de cada meta-análisis)

****E**** (Exposición) | ¿Qué factor? | Autoestima y/o autoconcepto medidos con instrumentos validados

****C**** (Comparación) | ¿Comparado con qué? | Grupos control sin diagnóstico (cuando aplica) o grupos con distinto nivel de autoestima

****O**** (Outcome) | ¿Qué resultado? | Bienestar en cualquiera de sus dimensiones (subjetivo, psicológico, HRQoL, salud mental)

2.4 La estrategia de búsqueda: bloques semánticos

La estrategia de búsqueda se construye con operadores booleanos:

BLOQUE 1 (Predictor)

("self-esteem" OR "self-concept" OR "self-worth" OR "self-image" OR "RSES"
OR "Rosenberg" OR "SDQ" OR "self-description" OR "self-perception")

AND

BLOQUE 2 (Outcome)

("wellbeing" OR "well-being" OR "quality of life" OR "mental health"
OR "HRQoL" OR "life satisfaction" OR "psychological well-being"
OR "subjective well-being" OR "flourishing")

AND

BLOQUE 3 (Diseño)

("meta-analysis" OR "meta analysis" OR "systematic review"
OR "umbrella review" OR "overview of reviews" OR "meta-analytic")

Esta estrategia se adapta a la sintaxis específica de cada base de datos (MeSH en PubMed, Thesaurus en PsycInfo, etc.).

2.5 Bases de datos y literatura gris

Bases de datos primarias

PubMed: base de datos biomédica de referencia (NLM/NIH). Acceso libre. Usa vocabulario controlado MeSH.

APA PsycInfo: base de datos de referencia en psicología. Cobertura exhaustiva de revistas de psicología.

Scopus: base multidisciplinar de Elsevier. Amplia cobertura de revistas internacionales.

Web of Science: base multidisciplinar de Clarivate. Muy usada para análisis bibliométrico.

Literatura gris (estudios no publicados en revistas)

La literatura gris es fundamental para reducir el sesgo de publicación (solo se publican estudios con resultados positivos).

ProQuest Dissertations: tesis doctorales.

Google Scholar: búsqueda amplia incluyendo informes y working papers.

OpenDOAR: repositorios de acceso abierto.

DART-Europe: tesis europeas.

TESEO: tesis doctorales españolas.

2.6 La herramienta Rayyan

Rayyan es una aplicación web gratuita diseñada específicamente para gestionar las fases de cribado en revisiones sistemáticas. Permite:

- Importar referencias de múltiples bases de datos.
- Eliminar duplicados automáticamente.
- Clasificar estudios como "include" / "exclude" / "maybe" con justificación.
- Si hay dos revisores, calcula el acuerdo inter-jueces.
- Mantiene un registro de auditoría de todas las decisiones.

2.7 AMSTAR-2: evaluación de calidad en profundidad

AMSTAR-2 tiene **16 items**. Los **7 items críticos** son los que determinan principalmente la calificación global:

Item crítico | Pregunta | Por qué es crítico

2 | ¿Se preregistró el protocolo antes de iniciar la revisión? | Previene hipótesis post-hoc y sesgo de análisis

4 | ¿La estrategia de búsqueda fue exhaustiva? (≥ 2 bases + gris) | Garantiza cobertura del corpus

7 | ¿Se justificaron las exclusiones de estudios? | Transparencia en la selección

9 | ¿Se evaluó el riesgo de sesgo de los estudios primarios? | Calidad de la materia prima

11 | ¿Se usaron métodos apropiados de meta-análisis? | Validez de la síntesis cuantitativa

13 | ¿Se tuvo en cuenta el riesgo de sesgo al interpretar? | Honestidad de las conclusiones

15 | ¿Se evaluó el sesgo de publicación y se discutió su impacto? | Control del sesgo sistemático

Clasificación global AMSTAR-2:

- **Alta:** no falla ningún ítem crítico (máximo 1 no crítico)
- **Moderada:** falla 1 ítem crítico (con o sin no críticos)
- **Baja:** falla más de 1 ítem crítico
- **Criticamente baja:** falla múltiples ítems críticos

2.8 El CCA: índice de solapamiento corregido

El **CCA** (Corrected Covered Area) mide qué proporción de estudios primarios están compartidos entre los meta-análisis incluidos.

Formula:

$$CCA = (N_{\text{solapados}} - k) / (N_{\text{total}} - k)$$

Donde:

- $N_{\text{solapados}}$ = suma de todos los estudios primarios en todos los meta-análisis
- k = número de estudios únicos
- $N_{\text{total}} = N_{\text{solapados}}$ (el total posible de combinaciones)

Interpretación:

- **CCA < 5%:** solapamiento leve → resultados independientes, conclusiones robustas ✓
- **CCA 5-10%:** solapamiento moderado → interpretar con cautela
- **CCA 10-15%:** solapamiento alto → riesgo de pseudoreplicación
- **CCA > 15%:** solapamiento muy alto → las conclusiones están comprometidas

En este TFM: **CCA = 1,4%** → solapamiento leve, corpus válido para revisión paraguas.

PARTE 3 -- RESULTADOS EN PROFUNDIDAD

3.1 Proceso de selección: el diagrama PRISMA

El proceso de selección sigue el diagrama de flujo PRISMA con cuatro fases:

```
IDENTIFICACION
↓
Registros en bases de datos: ~X (no especificado en la info disponible)
↓
CRIBADO (por título y resumen)
↓
Registros cribados → excluidos por no cumplir criterios básicos
↓
ELEGIBILIDAD (por texto completo)
↓
Evaluados en texto completo → excluidos con razón
↓
INCLUSION
↓
13 meta-análisis incluidos en la revisión paraguas
```

3.2 Características del corpus (los 13 meta-análisis)

Característica | Rango / Valor
Número de estudios por meta-análisis (k) | 7 - 114
Mediana de k | 19
Estudios primarios totales (aproximados) | ~415
CCA | 1,4%
Periodo de publicación | 2016-2026
Idiomas | Inglés (mayoría), algunos con resumen en español

Distribución por condición clínica:

- **5 meta-análisis:** trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, TDAH, suicidalidad, trastornos del comportamiento)
- **3 meta-análisis:** obesidad y sobrepeso infantojuvenil
- **2 meta-análisis:** salud reproductiva y población transgénero/no binaria
- **1 meta-análisis:** trastornos orofaciales (deformidades dentofaciales)
- **1 meta-análisis:** víctimas de violencia (doméstica, bullying)
- **1 meta-análisis:** baja autoestima como condición clínica en sí misma

3.3 Calidad metodológica del corpus (AMSTAR-2)

Calidad | Número de meta-análisis | Porcentaje
Alta | 1 | 8%
Moderada | 0 | 0%
Baja | 6 | 46%
Críticamente baja | 6 | 46%

Interpretación: Solo 1 de 13 meta-análisis alcanza el estándar de calidad óptimo. El 92% del corpus tiene deficiencias metodológicas. Los problemas más frecuentes detectados en AMSTAR-2 son:

- Ausencia de preregistro (ítem crítico 2)
- No evaluación del riesgo de sesgo de estudios primarios (ítem crítico 9)
- No evaluación del sesgo de publicación (ítem crítico 15)
- Búsquedas que omiten literatura gris (ítem crítico 4)

3.4 Síntesis de resultados por bloques

BLOQUE A -- Suicidalidad y salud mental

Meta-análisis central: estudio sobre ideación suicida, conducta suicida y autoestima.

Datos clave:

- k = 114 estudios primarios (el mayor del corpus)
- Calidad AMSTAR-2: **Alta** (único en el corpus)
- Tamaño del efecto: $r = -.26$ a $-.44$ (negativo porque mayor autoestima $\rightarrow$ menor riesgo)
- Interpretación según Cohen: efectos de pequeño-moderado a moderado-grande

¿Que significa clínicamente? Una correlación de $-.44$ entre autoestima y suicidalidad es un efecto sustancial. Para ponerlo en perspectiva: es comparable al efecto de muchos factores de riesgo conocidos para la conducta suicida. Significa que la autoestima baja es un predictor clínicamente relevante del riesgo

suicida, con suficiente tamaño de efecto para justificar su inclusión en protocolos de evaluación del riesgo.

Otros meta-análisis del Bloque A: incluyen meta-análisis sobre autoestima en trastornos depresivos, trastorno de ansiedad social y TDAH. Los efectos son consistentemente negativos (mayor autoestima -> mejor salud mental), con r en el rango .25-.45.

BLOQUE B -- Salud somática (PCOS y deformidad dentofacial)

PCOS (Síndrome de Ovario Poliquístico):

- Condición endocrina crónica que afecta al 5-10% de mujeres en edad fértil.
- Síntomas como hirsutismo, acné, irregularidades menstruales e infertilidad tienen un fuerte impacto en la imagen corporal y el autoconcepto femenino.
- El meta-análisis del corpus muestra que la autoestima y la calidad de vida (HRQoL) están significativamente correlacionadas en esta población.

Deformidad dentofacial:

- Las malformaciones orofaciales afectan la apariencia física, que es una dimensión central del autoconcepto físico.
 - El meta-análisis incluido muestra que el autoconcepto y la satisfacción con la imagen corporal predicen la HRQoL en pacientes sometidos a cirugía ortognática.
-

BLOQUE C -- Obesidad pediátrica

Contexto: La obesidad infantojuvenil es una condición clínica con consecuencias psicológicas documentadas, entre ellas deterioro del autoconcepto físico y la autoestima global.

Datos clave:

- 3 meta-análisis en este bloque
- Tamaño del efecto para autoestima global: **SMD $\approx$ 0,34** (pequeño-moderado según Cohen)
- Tamaño del efecto para imagen corporal: **SMD $\approx$ 0,47** (moderado)
- Los niños con obesidad tienen peor autoestima y peor autoconcepto físico que los controles

Hallazgo diferencial importante: Las intervenciones (aunque no sean el foco de este TFM) que trabajan específicamente la imagen corporal y el autoconcepto físico muestran efectos sobre el bienestar mayores que las que solo trabajan la autoestima global. Esto sugiere que el autoconcepto multidimensional tiene más poder predictivo que la autoestima global en este contexto.

BLOQUE D -- Imagen corporal en trastornos clínicos (afirmación de género)

Contexto: La disforia de género es la experiencia de malestar o incongruencia entre el género asignado al nacer y la identidad de género. El tratamiento de afirmación de género (hormonal y/o quirúrgico) busca alinear la apariencia corporal con la identidad de género.

Datos clave:

- 2 meta-análisis en este bloque
- Calidad: **Baja** en ambos
- Tamaños del efecto: **$g = -.46$ a $-.99$** (moderados a grandes)

- Direccion: la afirmacion de genero mejora el autoconcepto corporal y esto se asocia con mejoras en bienestar

Por que los efectos son tan grandes: La disforia de genero produce una discrepancia severa y cronica entre el cuerpo percibido y la identidad. La resolucion de esa discrepancia (a traves de la afirmacion) puede producir cambios profundos en el autoconcepto y, consecuentemente, en el bienestar. Sin embargo, la baja calidad metodologica exige cautela: el sesgo de publicacion puede estar inflando estos efectos.

BLOQUE E -- Autoconcepto como mediador (MASEM)

¿Que es el MASEM?

El **Meta-Analytic Structural Equation Modelling** combina las matrices de correlacion de multiples meta-analisis para ajustar un modelo de ecuaciones estructurales. Es la tecnica mas sofisticada del corpus.

Modelo ajustado:

Variable clinica (gravedad) -> Autoconcepto (mediador) -> Bienestar (outcome)

Resultado:

- Efecto indirecto estandarizado: **beta = $-.189$**
- Este efecto es estadisticamente significativo
- El autoconcepto media parcialmente (no totalmente) la relacion entre gravedad clinica y bienestar

¿Que significa "mediar parcialmente"? Que la enfermedad afecta al bienestar tanto por mecanismos directos (dolor, limitacion funcional, tratamiento...) como por mecanismos indirectos que pasan por el autoconcepto. El autoconcepto es uno de esos mecanismos, pero no el unico. El $\beta = -.189$ cuantifica la parte del efecto que va a traves del autoconcepto.

Implicacion clinica directa: Si el autoconcepto es un mecanismo mediador, entonces intervenirlo puede romper la cadena causal entre enfermedad y deterioro del bienestar. Es decir: mejorar el autoconcepto del paciente puede mejorar su bienestar independientemente de que la condicion medica mejore.

PARTE 4 -- DISCUSION EN PROFUNDIDAD

4.1 Las cuatro conclusiones principales y su justificacion

Conclusion 1: La autoestima y el autoconcepto son predictores robustos del bienestar en poblaciones clinicas.

Justificacion: Los 13 meta-analisis, con todo tipo de condiciones clinicas y medidas de bienestar, muestran asociaciones en la misma direccion: mayor autoestima/autoconcepto -> mayor bienestar. La consistencia a traves de poblaciones y medidas muy distintas es evidencia de robustez.

Conclusion 2: Los efectos son coherentes con la literatura general pero algo mayores en contextos clinicos.

Justificacion: Zell y Johansson (2025) obtienen $r = .31$ en poblacion general. Los meta-analisis del Bloque A (salud mental) obtienen $r \approx .42$. La diferencia sugiere que en situaciones de vulnerabilidad (diagnostico clinico), la percepcion de uno mismo tiene un impacto mas pronunciado. Hipotesis explicativa: en condiciones adversas, los recursos psicologicos como la autoestima actuan como buffer de las consecuencias del estres.

Conclusion 3: La calidad metodologica del campo es insuficiente.

Justificacion: 92% del corpus con calidad Baja o Criticamente baja. Los fallos mas frecuentes son estructurales (ausencia de preregistro, no evaluacion del sesgo de publicacion) y no accidentales. Refleja un estandar de practica del campo que necesita elevar sus exigencias metodologicas.

Conclusion 4: El autoconcepto funciona como mecanismo mediador activo.

Justificacion: El MASEM del Bloque E con $\beta = -.189$ ofrece evidencia preliminar de mediacion. Es "preliminar" porque la causalidad no puede establecerse con certeza en estudios transversales, pero el modelo es teoricamente coherente y consistente con el marco de Shavelson.

4.2 Comparacion con Zell y Johansson (2025)

Aspecto	Zell & Johansson (2025)	TFM Antoneac (2026)
Tipo de sintesis	Meta-analisis	Revision paraguas
Correlacion global	$r^* = .31$	No calculada globalmente
Poblacion	General + clinica mezclada	Exclusivamente clinica ($\geq 75\%$)
Constructo predictor	Solo autoestima	Autoestima + autoconcepto
Outcome	Bienestar amplio	Bienestar + HRQoL + salud mental
Periodo	No especificado	2016-2026
Evaluacion calidad	No reportada	AMSTAR-2 sistematico

4.3 Implicaciones clinicas: expansion

Implicacion 1 -- COMET y terapia de Fennell

COMET (*Competitive Memory Training*): Programa desarrollado por Korrelboom et al. Basado en la teoria del aprendizaje competitivo. La premisa es que los recuerdos negativos sobre uno mismo son mas accesibles que los positivos en personas con baja autoestima. COMET entrena la recuperacion de recuerdos positivos de exito, competencia y valia. Reduce la "ventaja de recuperacion" de los esquemas negativos. Tiene evidencia en trastornos de la alimentacion, depresion y trastorno limite de la personalidad.

Terapia cognitiva de Fennell (*Overcoming Low Self-Esteem*): Protocolo cognitivo conductual centrado en identificar y modificar el "esquema nuclear negativo" sobre uno mismo. Trabaja las reglas disfuncionales, los comportamientos de seguridad y los efectos del estado de animo sobre el autoconcepto. Fennell distingue el "esquema incondicional" ("soy malo") del "esquema condicional" ("si no logro X, soy un fracasado"). El trabajo terapeutico aborda ambos niveles.

Implicacion 2 -- Evaluacion multidimensional del autoconcepto

La RSES (10 items) mide solo autoestima global. En contextos clinicos donde el autoconcepto fisico o el autoconcepto social son relevantes (obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, afirmacion de genero, trastorno de ansiedad social), anadir el SDQ o el PSDQ (autoconcepto fisico especifico)

proporciona una evaluación más precisa y con mayor poder predictivo sobre el bienestar específico.

Implicación 3 -- Cribado en prevención suicida

La RSES cumple los criterios básicos para ser un indicador de cribado: es breve (10 ítems, 2-3 minutos), gratuita, con propiedades psicométricas robustas en múltiples poblaciones y culturas, y --según los resultados del Bloque A-- con correlación de hasta $-.44$ con suicidalidad. Anadirla a protocolos de triaje en urgencias psiquiátricas, atención primaria y servicios de salud mental escolar sería una medida de bajo coste y posiblemente alta rentabilidad preventiva.

PARTE 5 -- LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS: ANALISIS PROFUNDO

5.1 Limitaciones del proceso

Revisora única: el problema real

En revisiones sistemáticas, el acuerdo inter-jueces se mide con el **kappa de Cohen (kappa)**:

- kappa < 0.20 : acuerdo pobre
- kappa $0.21-0.40$: acuerdo discreto
- kappa $0.41-0.60$: acuerdo moderado
- kappa $0.61-0.80$: acuerdo sustancial ✓ (lo que se busca en revisiones sistemáticas)
- kappa > 0.80 : acuerdo casi perfecto

Sin un segundo revisor, este índice no se puede calcular y no hay garantía de que las decisiones de inclusión/exclusión sean reproducibles. Es el talón de Aquiles metodológico del trabajo.

Restricción de idioma

Solo se incluyeron estudios en español e inglés. La ciencia psicológica se publica mayoritariamente en inglés, pero hay investigación relevante en alemán, chino, portugués, japonés... Algunos meta-análisis sobre poblaciones específicas (asiáticas, latinoamericanas) pueden haber sido excluidos por este criterio.

5.2 Limitaciones del corpus

Ausencia de preregistro en la mayoría del corpus

El preregistro en PROSPERO permite verificar que los objetivos, criterios y análisis se definieron a priori y no post-hoc. Que el 92% del corpus no esté preregistrado aumenta la posibilidad de que los resultados estén sesgados por decisiones analíticas no planificadas (p-hacking, outcome switching).

Heterogeneidad sin explicar

Los meta-análisis reportan estadísticos de heterogeneidad (I^2 , τ^2). Muchos presentan I^2 alto ($>75\%$), lo que indica que la varianza en los tamaños del efecto no se explica solo por el error de muestreo, sino por diferencias reales entre estudios (moderadores no identificados). Esto limita la interpretación del tamaño del efecto "promedio".

5.3 Líneas de investigación futuras: por qué cada una importa

Prerregistro en PROSPERO: haria la revision reproducible y auditable. PROSPERO es la base de datos internacional de protocolos de revisiones sistematicas.

Estudios longitudinales: los disenos transversales actuales no permiten establecer causalidad. Un estudio longitudinal con medidas de autoestima en T1 y bienestar en T2 (controlando T1 de bienestar) permitiria inferencia causal mas solida.

Autoconcepto multidimensional: la mayoria del corpus usa autoestima global (RSES). Incluir SDQ multidimensional permitiria identificar que dimensiones del autoconcepto (fisico, social, academico) son mas relevantes para que outcomes en que poblaciones.

Poblaciones mayores y no occidentales: la literatura sobre self y bienestar esta dominada por muestras jovenes, universitarias y occidentales (el llamado problema WEIRD: Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Los mayores y las culturas colectivistas pueden tener estructuras del self muy distintas.

Network meta-analysis (NMA): permitiria comparar indirectamente distintas intervenciones sobre autoestima/autoconcepto, incluso cuando no existen comparaciones directas entre ellas en los estudios primarios. Es el siguiente nivel de sintesis para guiar la seleccion de intervenciones clinicas.

PARTE 6 -- CONCEPTOS ESTADISTICOS CLAVE

Tamanos del efecto: guia rapida

Metrica | Pequeno | Mediano | Grande | Uso tipico

r de Pearson | .10 | .30 | .50 | Correlacion entre variables continuas

d de Cohen | 0.2 | 0.5 | 0.8 | Diferencia entre dos grupos

g de Hedges | 0.2 | 0.5 | 0.8 | Igual que *d*, corregido para n pequenas

beta (regresion) | .10 | .30 | .50 | Efecto en modelos de ecuaciones estructurales

I² (heterogeneidad)

I² mide que porcentaje de la varianza en los tamanos del efecto se debe a diferencias reales entre estudios (no al azar):

- I² < 25%: heterogeneidad baja
- I² 25-75%: heterogeneidad moderada
- I² > 75%: heterogeneidad alta (las diferencias entre estudios son grandes; el promedio global tiene menos sentido)

Modelos de efectos

- **Modelo de efectos fijos:** asume que todos los estudios estiman el mismo efecto real. Apropiado cuando la heterogeneidad es minima.
 - **Modelo de efectos aleatorios:** asume que cada estudio estima un efecto real propio, y estos efectos siguen una distribucion normal alrededor de un efecto promedio. Es el estandar actual y el mas apropiado cuando hay heterogeneidad.
-

RESUMEN EJECUTIVO: LO MAS IMPORTANTE PARA NO OLVIDAR

El TFM es una revision paraguas de 13 meta-analisis sobre autoestima/autoconcepto y bienestar en poblaciones clinicas, periodo 2016-2026.

El CCA es 1,4%: solapamiento minimo, corpus valido.

La calidad es mala: solo 1/13 con calidad Alta (AMSTAR-2). El 92% es Bajo o Criticamente bajo.

Los efectos existen y son consistentes: autoestima/autoconcepto se asocian negativamente con malestar y positivamente con bienestar en todas las poblaciones clinicas estudiadas.

Los efectos mas robustos son los de suicidalidad (Bloque A, $k=114$, calidad Alta, r hasta $-.44$).

Los efectos mas grandes son los de afirmacion de genero (Bloque D, g hasta $-.99$), pero con calidad Baja.

El autoconcepto media la relacion enfermedad-bienestar (Bloque E, $\beta = -.189$), lo que lo convierte en diana terapeutica.

La limitacion principal es la revisora unica: sin kappa inter-jueces, la seleccion no es auditablemente reproducible.

Las tres implicaciones clinicas son: (a) autoestima como diana terapeutica directa (COMET, Fennell), (b) evaluacion multidimensional del autoconcepto, (c) RSES como herramienta de cribado en prevencion suicida.

El trabajo es coherente con Zell y Johansson (2025) ($r = .31$ global) pero muestra efectos algo mayores en poblaciones clinicas puras.

[FIN DEL DOCUMENTO DE GUIA PROFUNDA]